

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE CONDUCTOS (ENDODONCIA)

HISTORIA CLÍNICA N.º: _____

FECHA: ____ / ____ / ____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre completo: _____

Documento de
Identidad: _____

Edad: _____

Teléfono: _____

ODONTÓLOGO TRATANTE

Nombre: _____

Registro profesional: _____

DIENTE A TRATAR

Arcada:

■ Superior

■ Inferior

Cuadrante: _____

Diente: _____

Diagnóstico pulpar: _____

Diagnóstico periapical: _____

Hallazgos radiográficos: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO

Yo, _____, identificado(a) con documento de identidad N.º _____, declaro que he recibido información clara, suficiente y comprensible acerca del tratamiento endodóntico que será realizado en el diente anteriormente descrito.

Comprendo que el tratamiento de conductos tiene como objetivo eliminar el tejido pulpar inflamado, infectado o necrótico del interior del diente, desinfectar el sistema de conductos radiculares y sellarlo tridimensionalmente para preservar el órgano dental dentro de la cavidad oral.

Entiendo que este procedimiento busca mantener el diente funcional, evitando su extracción cuando las condiciones clínicas lo permiten.

PROTOCOLO CLÍNICO DEL PROCEDIMIENTO

Se me ha explicado que el tratamiento podrá incluir una o varias de las siguientes fases:

- | | |
|---|---|
| ■ Evaluación clínica. | ■ Determinación de longitud de trabajo mediante localizador apical y/o radiografía. |
| ■ Evaluación radiográfica. | ■ Instrumentación biomecánica de los conductos. |
| ■ Interpretación de radiografías periapicales y/o tomografía. | ■ Irrigación química con soluciones desinfectantes. |
| ■ Diagnóstico pulpar y periapical. | ■ Colocación de medicación intracanal cuando esté indicada. |
| ■ Pruebas de sensibilidad pulpar. | ■ Obturación tridimensional del sistema de conductos. |
| ■ Aplicación de anestesia local. | ■ Restauración provisional. |
| ■ Aislamiento absoluto mediante dique de goma. | ■ Restauración definitiva posterior. |
| ■ Apertura cameral. | ■ Controles clínicos y radiográficos. |
| ■ Localización de conductos radiculares. | |

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

Comprendo que los beneficios esperados incluyen:

- Conservación del diente natural.
- Eliminación de infección pulpar.
- Eliminación o disminución del dolor.
- Resolución de lesiones periapicales cuando sea posible.
- Recuperación de la función masticatoria.
- Prevención de infecciones futuras.
- Evitar la extracción dental cuando el pronóstico lo permite.

LIMITACIONES DEL TRATAMIENTO

Comprendo que la anatomía interna de los dientes presenta variaciones individuales y que algunos conductos pueden ser extremadamente estrechos, calcificados, curvos, bifurcados o difíciles de localizar.

Entiendo que el éxito del tratamiento depende de múltiples factores, incluyendo:

- Diagnóstico inicial.
- Estado periodontal.
- Extensión de la infección.
- Calidad de la restauración definitiva.
- Estado estructural del diente.
- Cumplimiento de controles posteriores.
- Respuesta biológica individual.

Comprendo que ningún tratamiento endodóntico puede garantizar un resultado exitoso al 100%.

RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

Comprendo que pueden presentarse complicaciones inherentes al procedimiento, incluyendo:

- Dolor postoperatorio.
- Sensibilidad durante varios días.
- Inflamación local.
- Persistencia o recurrencia de infección.
- Absceso posterior al tratamiento.
- Retraso en la cicatrización periapical.
- Necesidad de retratamiento endodóntico.
- Necesidad de cirugía periapical futura.
- Necesidad de extracción dental futura.
- Cambio de color del diente tratado.
- Debilitamiento estructural del diente.
- Fractura coronaria.
- Fractura radicular.
- Pérdida del sellado coronario.

COMPLICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Comprendo que debido a la complejidad anatómica del sistema de conductos pueden ocurrir:

- Conductos accesorios no detectados.
- Conductos calcificados.
- Conductos obliterados.
- Escalones durante la instrumentación.
- Transporte del conducto.
- Extrusión accidental de material de obturación.
- Sobreinstrumentación.
- Subinstrumentación.
- Obturación incompleta.
- Fractura de instrumentos endodónticos dentro del conducto.
- Imposibilidad de retirar instrumentos fracturados.
- Necesidad de remisión a especialista en endodoncia.
- Perforación radicular.
- Perforación cameral.
- Extrusión accidental de irrigantes.

ACCIDENTES RELACIONADOS CON LOS IRRIGANTES

Comprendo que durante la desinfección de los conductos pueden utilizarse soluciones químicas que, aunque seguras bajo protocolos adecuados, pueden ocasionar accidentalmente:

- Dolor intenso.
- Inflamación.
- Sangrado.
- Hematoma.
- Lesión de tejidos blandos.
- Reacciones inflamatorias locales.
- Necesidad de manejo adicional.

NECESIDAD DE RESTAURACIÓN DEFINITIVA

Comprendo que una vez finalizado el tratamiento endodóntico será indispensable realizar la restauración definitiva indicada por el profesional.

Se me ha explicado que la ausencia de una restauración adecuada puede ocasionar:

- Fractura del diente.
- Filtración bacteriana.
- Recontaminación del sistema de conductos.
- Fracaso del tratamiento.
- Pérdida del diente.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ANESTESIA LOCAL

Comprendo que la anestesia local puede ocasionar:

- Dolor en el sitio de punción.
- Hematoma.
- Inflamación.
- Trismus.
- Parestesia temporal.
- Reacciones alérgicas.
- Palpitaciones transitorias.
- Síncope vasovagal.
- Complicaciones médicas poco frecuentes.

SITUACIONES CLÍNICAS IMPREVISIBLES

Entiendo que durante el tratamiento pueden descubrirse condiciones no evidenciadas inicialmente, tales como:

- Fracturas radiculares.
- Reabsorciones internas.
- Reabsorciones externas.
- Perforaciones preexistentes.
- Conductos adicionales.
- Calcificaciones severas.
- Defectos estructurales extensos.
- Pronóstico desfavorable del diente.

Autorizo al profesional para modificar razonablemente el plan de tratamiento cuando sea necesario para preservar mi salud oral.

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se me ha informado que las alternativas pueden incluir:

- Observación clínica cuando esté indicada.
- Tratamiento paliativo temporal.
- Retratamiento endodóntico.
- Cirugía periapical.
- Exodoncia.
- No realizar tratamiento, comprendiendo los riesgos asociados.

INDICACIONES POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO

Comprendo que debo:

- Cumplir la medicación prescrita.
- Asistir a los controles indicados.
- Evitar masticar alimentos duros sobre el diente tratado hasta su restauración definitiva.
- Informar cualquier dolor intenso, inflamación o complicación.
- Realizar oportunamente la restauración definitiva indicada.

DECLARACIÓN DEL PACIENTE
